

起的心脏功能障碍；③心室纤颤；④传导阻滞。杜显刚等^[5]报道的 26 例死亡案例中，8 例死于钝器伤后，8 例死于剧烈运动及情绪激动后，3 例死于饱餐及饮酒后，1 例死于急性一氧化碳中毒后，仅 6 例无明显诱因，死于平静状态或睡眠中。

本案例中，虽然死者生前曾发生争执、推搡，并后枕部着地，但经过对其颅脑及颈髓的系统法医学检查，并未发现致命性损伤，并且未见脑白质变性、神经收缩球等弥漫性轴索损伤症状，排除机械性暴力导致的死亡。酒精及常见药毒物筛查排除了中毒致死的可能。左冠状动脉前降支肌桥形成，冠状动脉粥样硬化症，以及多器官淤血、水肿等改变，综合分析认为本案例中死者符合左冠状动脉前降支肌桥引起心源性猝死。

参 考 文 献

- [1] ISHII T, ISHIKAWA Y, AKASAKA Y. Myocardial bridge as a structure of "double-edged sword" for the coronary artery [J]. Ann Vasc Dis, 2014, 7(2): 99-108.
- [2] Alegria JR. Myocardial bridging. European Heart Journal [J]. 2005;26(12): 1159-1168.
- [3] 官大威, 赵锐. 冠状动脉肌桥与心源性猝死 [J]. 中国法医学杂志, 2010, 25(6): 404-407.
- [4] ANANDA S, ZHU S H, REN L, et al. Unexpected death of a young woman: is myocardial bridging significant?-a case report and review of literature [J]. Forensic Science, Medicine, and Pathology, 2011, 7(1): 42-46.
- [5] 杜显刚, 官鹏, 张志威, 等. 26 例冠状动脉肌桥法医学病理学研究 [J]. 法医学杂志, 2003, 19(4): 215-216.

(收稿日期: 2015-12-03)

· 案例分析 ·

足月小样儿并发肺出血死亡 1 例

梁 悦¹, 霍少明², 童 昉¹, 张 琳¹, 李文鹤¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 鄂州市公安局刑警支队, 湖北 鄂州 436000)

【关键词】法医病理学; 足月小样儿; 肺出血; 巨细胞病毒; 医疗纠纷

【中图分类号】DF795.4

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728(2016)03-0304-02

doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2016.03.031

1 病例资料

1.1 简要病情

某女, 26 岁, 孕 2 产 1, 产前检查巨细胞病毒 IgG (+)。某日于某市妇幼保健院产下一对龙凤胎, Apgar 评分均为 10 分, 男婴体重 2.94kg, 发育良好, 心肺功能正常。女婴体重 2.48kg, 因足月生后体重低, 于 20min 后收入新生儿科。查体: 成熟新生儿外貌, 反应一般, 无呻吟, 呼吸表浅, 双肺呼吸音粗糙。入院诊断“足月小样儿”。2d 后突发氧饱和度下降,

昏迷, 皮肤发绀, 嘴唇发紫, 经抢救无效死亡。病史资料: 孕 12 周 CMV IgG (+)。

1.2 法医学检验

尸表检验 女性新生儿尸体, 尸斑暗红, 睑球结合膜出血, 口唇紫绀, 指(趾)甲床发绀。

尸体解剖 头皮无损伤, 前囟未闭合, 直径 1.5cm, 颅骨未见骨折。脑重 327.0g, 脑轻度水肿, 脑回变宽, 脑沟变浅。左肺重 18.0g, 右肺重 23.0g, 双肺切面灶性实变, 色泽暗红, 支气管内有淡红色液体。心脏及腹腔、盆腔各脏器未检见异常。

病理学检验 镜下肺泡扩张, 大部分肺泡腔及部分小支气管内充满大量红细胞及血浆(图 1), 少数区域肺泡壁透明膜形成(图 2), 肺泡腔内偶见少量角化鳞状上皮等羊水成分, 灶性肺泡不张; 部分肾小管见蛋白管型, 肾盂间质多发性灶片状出血。

【基金项目】国家自然科学基金面上项目(81273336)

【作者简介】梁悦, 女, 硕士研究生, 主要研究方向: 法医病理学, E-mail: yueyueashin@126.com

【通信作者】周亦武, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学、法医毒理学教学、检案及研究。E-mail: yiwuhedi@sina.com

诊断: ①足月小样儿并发肺出血及透明膜形成;
②肾间质灶片状出血。

死亡原因 结合现有案情、病历资料、死亡经过及病理学检查所见, 综合分析, 该新生儿系足月小样儿并发肺出血致急性呼吸功能衰竭而死亡。

2 讨 论

凡出生体重在同胎龄正常体重平均值的 2 个标准差以下或第 10 个百分位数以下者在临床上均称为小样儿或小于胎龄儿 (small for gestational age, SGA), 发病率为 2.3%~10%^[1]。其中, 胎龄在 37~42 周之间, 胎儿出生体重在 2 500g 以下者, 称足月小样儿, 亦称足月低体重儿, 死亡率为正常足月儿的 4~6 倍^[2]。

引起足月小样儿发生的危险因素甚多, 主要以母体状况、感染和营养不良等为主。母体危险因素包括孕妇年龄 >35 岁、印度或亚洲血统、身材矮小、体重轻、双胎或多胎、吸烟或被动吸烟等^[3-4]。本例中母亲孕双胎, CMV IgG (+), 均为足月小样儿发生的高危因素。

足月小样儿常见并发症有高胆红素血症、低糖血症、吸入性肺炎、新生儿窒息、新生儿缺氧缺血性脑病等^[2]。新生儿肺出血是新生儿的危急重症, 是足月小样儿罕见的晚期并发症, 发生在各种原发病症的晚期, 死亡率极高^[5]。有研究表明, CMV 感染可能是诱发新生儿肺出血的重要原因之一, 其机制可能是 CMV 毒素对肺组织直接损伤所致。本例中新生儿死者通过母婴传播, CMV IgG (+), 且体重低, 机体的功能相对不完善, 营养相对缺乏, 出生后免疫力也较低, 更易受到病毒的侵袭, 从而引发肺出血。此外, 本例新生儿肾间质出血, 同样为病毒感染致器官损伤的表现。

足月小样儿因易伴有多种并发症, 猝死的发生率高^[6], 且通过本例可知此类新生儿有并发肺出血的可能性, 故针对此类案件的法医学鉴定应注意:

①详细了解母亲的生活史、病史及新生儿的病历资料, 包括出生体重, 各类生化检查及死前临床表现; ②尸表检查时注意观察窒息征象及病理学改变, 如尸斑呈暗紫红色, 睑球结膜出血点, 口唇粘膜及指甲青紫等; ③除系统解剖外, 应着重对肺组织进行详细检查, 并提取两肺各叶做病理学检查; ④新生儿肺出血发病突然, 死亡迅速, 易引发医疗纠纷, 故作为法医, 除了进行尸检和死亡原因鉴定外, 还应根据此类疾病的特点, 对患儿家属进行客观、耐心地解释, 维护和谐的医患关系。

(本文图 1、2 见彩插 I)

参 考 文 献

- [1] BOGUSZEWSKI M C, MERICQ V, BERGADA I, et al. Latin American consensus: children born small for gestational age [J]. BMC pediatrics, 2011, 11: 66.
- [2] 丁月琴, 陈志凤, 李锐钦. 足月小样儿 74 例常见并发症分析 [J]. 基层医学论坛, 2012, 16(4): 422-423.
- [3] LESLEY MC, HORGAN R P. Risk factors for small for gestational age infants [J]. Best practice & research Clinical obstetrics & gynaecology, 2009, 23 (6): 779-793.
- [4] 冷海娜, 郭永, 宋婷婷. 足月小样儿发生的相关因素 [J]. 中国医疗前沿, 2008, 3(21):75.
- [5] 皇甫琴, 崔英波. 新生儿肺出血 56 例病因分析 [J]. 小儿急救医学, 2003, 10(4): 248.
- [6] HUNT C E. Small for gestational age infants and sudden infant death syndrome: a confluence of complex conditions [J]. Archives of disease in childhood Fetal and neonatal edition, 2007, 92 (6): 428-429.

(收稿日期: 2015-05-25)

多发性冠状动脉血栓形成猝死 1 例

(正文见 301 页)



图 1 左冠状动脉前降支大体所见

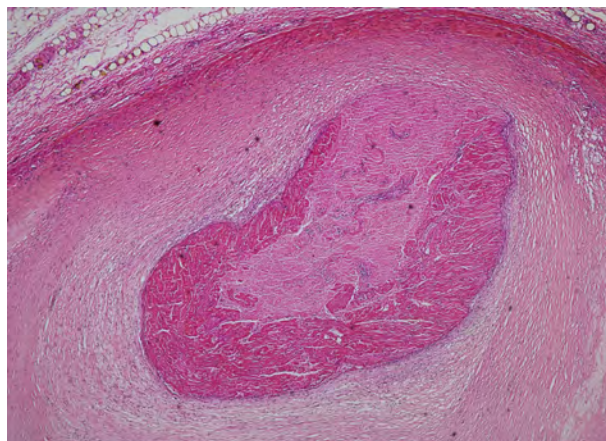


图 2 右冠状动脉主干内附壁血栓 (伴机化) HE×40

足月小样儿并发肺出血死亡 1 例

(正文见 304 页)

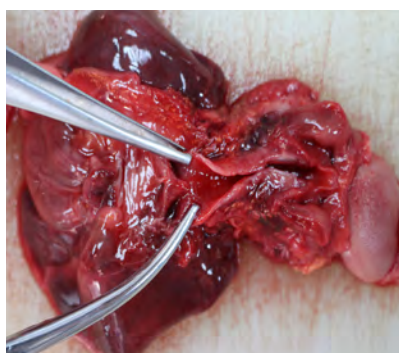


图 1 双肺呈暗红色, 支气管内有淡红色液体

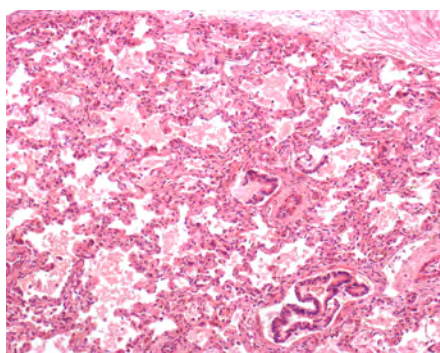


图 2 肺泡及细小支气管出血 HE×100

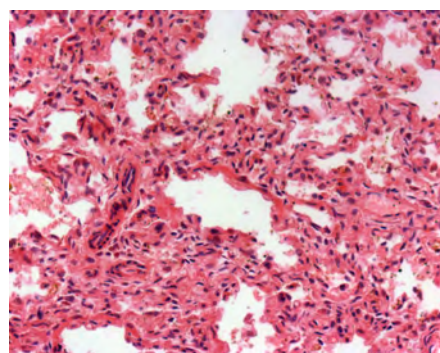


图 3 肺泡壁透明膜形成, 灶性肺不张 HE×200

2013(4): 88-95.

- [15] 茆巍. 论清代命案检验中的鉴定文书 [J]. 证据科学, 2011, 19(1): 20-30.
- [16] 张哲嘉. 中国传统法医学的知识性格与操作脉络 [J]. 台北“中央研究院”近代史研究所集刊, 2004: 44.
- [17] 瞿同祖. 清代地方政府 [M]. 北京: 法律出版社, 2011: 88-110.
- [18] 贾静涛. 世界法医学与法科学史 [M]. 北京: 科学出版社: 2000.
- [19] 黄瑞亭. 中国近现代法医学发展史 [M]. 福州: 福建教育出版社, 1997.

- [20] 刘鄂. 检验吏: 连接仵作与法医之间 [J]. 历史教学, 2012 (20): 15-21.
- [21] 李光和. 中国司法检验体制的近代化转型——以法医取代仵作为中心的历史考察 [J]. 历史档案, 2011(2): 117-124.
- [22] 茆巍. 从仵作到检验吏: 中国传统检验的转折——《吉林提法司第一次抱告书》开学照为起点 [J]. 证据科学, 2013, 21(3): 360-364.
- [23] 胡旭晟. 描述性的法史学与解释性的法史学——我国法史研究新格局评析 [J]. 法律科学, 1998(6): 38-43.

(收稿日期: 2015-05-07)